

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE RESILIENCIA DE CONNOR-DAVIDSON (CD-RISC)

Eje IV: Recursos y Adaptación • Cuantificación Psicométrica de la Capacidad de Resiliencia y Superación del Estrés

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Resiliencia de Connor-Davidson (Versiones CD-RISC-10 y CD-RISC-25).
Nombre Original	Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC; Connor & Davidson, 2003).
Autores Originales	Kathryn M. Connor, M.D. y Jonathan R. T. Davidson, M.D. (Duke University Medical Center, EE.UU.).
Adaptación Hispana	Bobes et al. (2001, 2008); Notario-Pacheco et al. (2011); Crespo et al. (2014); España y LatAm.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Recursos. Constructo multidimensional de resiliencia psicológica.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 10 o 25 reactivos balanceados con escala Likert de 5 puntos (0 a 4).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 15 años). Ámbitos clínico, psiquiátrico, laboral y comunitario.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos (CD-RISC-10) o 8 a 10 minutos (CD-RISC-25).
Régimen de Licencia	Propiedad de autor / Propietario (Connor & Davidson). Requiere acuerdo formal de uso académico.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CONSTRUCTO DE RESILIENCIA EN SALUD MENTAL

La **CD-RISC** fue diseñada para medir de forma estandarizada la capacidad humana para sobreponerse, prosperar y recobrar el equilibrio biopsicosocial tras experimentar eventos traumáticos, estrés vital crónico o pérdidas profundas. Connor y Davidson (2003) conceptualizaron la resiliencia no como una cualidad fija e inmutable, sino como una constelación dinámica de características cognitivas, afectivas y conductuales modificables:

1. **Competencia Personal y Autoeficacia:** Confianza en los propios recursos para perseverar ante metas desafiantes y tomar decisiones deliberadas en situaciones de incertidumbre.
2. **Tolerancia al Afecto Negativo y Fortalecimiento:** Capacidad de soportar el dolor emocional, la frustración y el cambio imprevisto sin recurrir a la evitación desadaptativa.
3. **Aceptación Positiva del Cambio y Vínculos Seguros:** Flexibilidad adaptativa para replantear crisis existenciales y capacidad de movilizar apoyo social íntimo.
4. **Control y Propósito Espiritual:** Locus de control interno y creencia en que los acontecimientos vitales poseen un sentido integrador.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (FORMAS DE 10 Y 25 REACTIVOS)

Versión / Factor	Nº Ítems	Contenido y Reactivos Clave Evaluados
CD-RISC-10 (Unidimensional)	10 reactivos	Forma breve de Campbell-Sills & Stein (2007): adaptación al cambio, tenacidad, superación de obstáculos.
F1: Competencia Personal	8 reactivos	Autoexigencia eficaz, disciplina de cumplimiento de metas y estándares elevados (versión 25 ítems).
F2: Confianza y Tolerancia	7 reactivos	Tolerancia al estrés extremo, calma bajo presión y capacidad de sobreponerse a fracasos.
F3: Aceptación del Cambio	5 reactivos	Aceptación de la impermanencia de las circunstancias y fortalecimiento vincular afectivo.
F4: Control Personal	3 reactivos	Locus de control interno sobre los propios resultados vitales y ausencia de indefensión.
F5: Influencias Espirituales	2 reactivos	Confianza en el destino, fe religiosa o sentido existencial trascendente del dolor.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones psicométricas españolas (Bobes et al., 2008; Notario-Pacheco et al., 2011; Crespo et al., 2014) respaldan la consistencia de ambas formas:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia CD-RISC-10	Alfa $\alpha = 0.85 - 0.89$	Excelente consistencia interna para la versión abreviada unidimensional.
Consistencia CD-RISC-25	Alfa $\alpha = 0.88 - 0.92$	Elevada homogeneidad en la forma completa de 25 reactivos.
Estabilidad Temporal	Test-retest $r = 0.87$	Reproducibilidad muy sólida comprobada a las 4 y 6 semanas.
Validez Convergente Negativa	$r = -0.48$ a -0.55	Fuerte correlación inversa con depresión (PHQ-9), ansiedad (GAD-7) y TEPT (PCL-5).
Sensibilidad Terapéutica	Tamaño efecto $d = 0.62$	Sensible al aumento de resiliencia tras intervenciones en trauma y psicoterapia cognitivo-conductual.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Formato de Gradación:** Escala Likert de 5 niveles que abarca el último mes:
- **En absoluto (0); Rara vez (1); A veces (2); A menudo (3); Casi siempre (4).**
- **Cálculo en la Versión Breve (CD-RISC-10):** Suma de los 10 reactivos:

$$\text{Puntuación Total CD-RISC-10} = \sum_{i=1}^{10} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 40 puntos})$$

- **Cálculo en la Versión Completa (CD-RISC-25):** Suma de los 25 reactivos:

$$\text{Puntuación Total CD-RISC-25} = \sum_{i=1}^{25} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 100 puntos})$$

- **Direccionalidad:** No existen ítems invertidos. Una mayor puntuación refleja mayor nivel de resiliencia y adaptabilidad psicológica.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Forma 10	Forma 25	Capacidad Adaptativa y Vulnerabilidad Clínica
Muy Baja	0 a 19 pts	0 a 49 pts	Vulnerabilidad severa; colapso ante el estrés, indefensión y alto riesgo clínico.
Baja	20 a 26 pts	50 a 64 pts	Resiliencia frágil; recursos limitados de afrontamiento; susceptible a ansiedad.
Moderada / Normal	27 a 33 pts	65 a 79 pts	Población general típica; capacidad adaptativa suficiente ante estresores ordinarios.
Alta / Sobre-saliente	34 a 40 pts	80 a 100 pts	Resiliencia excepcional; alta autoconfianza, tenacidad y recuperación activa tras trauma.

SIGNIFICACIÓN DE PUNTUACIONES CD-RISC-10 ≤ 23 PUNTOS:

Una puntuación en la versión breve inferior o igual a **23 puntos** (o < 60 en la forma de 25 ítems) es el punto de corte óptimo validado para discriminar riesgo de trastorno de adaptación, depresión mayor y trastorno de estrés postraumático ante crisis vitales agudas.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA EN PSICOTERAPIA

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN MODULAR BASADO EN EL CD-RISC:

- **Paso 1 (Cribado Inicial de Recursos):** Administrar el CD-RISC-10 al inicio del tratamiento para evaluar si el paciente dispone de capital psicológico basal para tolerar intervenciones de exposición.
- **Paso 2 (Estrategia ante Resiliencia Muy Baja [≤ 19]):** Contraindicar confrontaciones traumáticas precoces. Comenzar con psicoeducación en manejo fisiológico del estrés, grounding y restauración del sentido de seguridad.
- **Paso 3 (Entrenamiento en Autoeficacia y Reatribución Cognitiva):** Identificar situaciones previas en la vida del sujeto donde superó adversidades. Fortalecer el locus de control interno mediante tareas conductuales escalonadas.
- **Paso 4 (Evaluación de Ganancia Terapéutica):** Reevaluar el CD-RISC a los 3 y 6 meses. Un incremento sostenido de > 6 puntos en la forma abreviada es el mejor predictor clínico de prevención de recaídas a largo plazo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN TRAS PÉRDIDA LABORAL Y RUPTURA SENTIMENTAL

Identificación: Varón de 44 años, ingeniero técnico, consulta tras ser despedido por reestructuración empresarial simultáneamente a una ruptura matrimonial imprevista. Presenta rumiación constante de fracaso, parálisis motora, insomnio de conciliación e indefensión ("siento que no tengo fuerzas para empezar de cero a mi edad").

Evaluación Psicométrica Inicial:

- **Puntuación CD-RISC-10 = 14 / 40 puntos (Resiliencia Muy Baja;** Percentil 8 poblacional).
- **Reactivos críticos:** Ítem 1 (Capaz de adaptarse a los cambios) = 0/4; Ítem 5 (Recuperarse de dificultades) = 1/4; Ítem 8 (No rendirse con facilidad) = 1/4.
- **Comorbilidad asociada:** PHQ-9 = 15/27 (Depresión moderada); GAD-7 = 14/21 (Ansiedad moderada).

Formulación e Intervención Terapéutica: Cuadro de Trastorno Adaptativo Mixto con ansiedad y estado de ánimo deprimido inducido por colapso de autoeficacia. Se implementó Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) combinada con Terapia de Solución de Problemas (Nezu). Se trabajó en la aceptación del dolor sin resignación, clarificación de valores vocacionales y reactivación de redes de apoyo social.

Reevaluación a las 16 Semanas: El CD-RISC-10 ascendió notablemente a **31 / 40 puntos (Nivel Moderado-Alto)**, remitiendo la sintomatología ansioso-depresiva (PHQ-9 = 4) y comenzando un nuevo empleo consultor con actitud proactiva.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RESILIENCIA MUY BAJA Y RIESGO SUICIDA:

Un CD-RISC-10 < 12 en un paciente con depresión mayor se asocia a vivencia de impotencia absoluta e indefensión aprendida, constituyendo un marcador crítico de riesgo autolítico.

FALSA RESILIENCIA O HIPERCONTROL:

Puntuaciones máximas (40/40) en sujetos traumatizados recientes pueden reflejar disociación emocional defensiva o negación maníaca; explorar somatizaciones y consumo de alcohol.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). *Depression and Anxiety*, 18(2), 76-82.
2. Campbell-Sills, L., & Stein, M. B. (2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. *Journal of Traumatic Stress*, 20(6), 1019-1028.
3. Notario-Pacheco, B., et al. (2011). Reliability and validity of the Spanish version of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) in young adults. *Health and Quality of Life Outcomes*, 9, 63.
4. Crespo, M., Fernández-Lansac, V., & Soberón, C. (2014). Adaptación española de la escala de resiliencia de Connor-Davidson (CD-RISC) en situaciones de estrés crónico. *Ansiedad y Estrés*, 20(2), 219-232.